PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

2ª VARA CÍVEL DE TIMON

PROCESSO: 0802718-58.2024.8.10.0060

REQUERENTE: MARIA ALICE COIMBRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: FELIPE FRAGOSO MARIN (OAB 399983-SP), GLAUBER VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269130-SP), ALEXIS ELIANE (OAB 389822-SP), EDUARDO LEVY SASSI (OAB 422562-SP)

REQUERIDO: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s) do reclamado: THAIS HELEN BORGES MENDES (OAB 17365-MA)

SENTENÇA

I- RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARIA ALICE COIMBRA DA SILVA em face de HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., todos qualificados nos autos.

Alega a autora que foi "diagnosticada pelo reumatologista há 22 anos com fibromialgia (CID10: 79.7) com quadro clínico de dor generalizada e crônica, especialmente nos tecidos moles ao redor das articulações, fadiga persistente, distúrbios no sono, como insônia e sono não reparador, rigidez articular matinal, dificuldade de concentração e memória, associados a sintomas de ansiedade e depressão, fazendo uso prolongado de diversos medicamentos, de acordo com as diretrizes terapêuticas do SUS, bem como tratamento multidisciplinar, sem êxito,

sendo indicado pelo especialista o uso do medicamento *Bisaliv Power Full 1:100 - Cbd 20mg/Ml, Thc < 0,9% - Frasco 30ml E Bisaliv Power Full 20:1 - Cbd 1mg/Ml, Thc 20mg/Ml - Frasco 30ml*, à base de canabidiol".

Assevera que a parte demandada, sem justificativa plausível, negou a cobertura do custeio do tratamento.

Com a inicial, juntou os documentos de Id 114220542-pág.1 e ss.

Em decisão de Id 114412999 foi determinado que a autora completasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando comprovante de residência em seu nome, sob pena de indeferimento da inicial, cumprido em petitório de ID 115573651 e ss.

Em decisão de Id 122365303, foram deferidos os benefícios da Justiça gratuita e a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, indeferida a tutela de urgência postulada, remetidos os autos para a Central de Conciliação e, após a audiência, se acordo, a apresentação de contestação pelo demandado, especificando as provas que desejasse produzir, acostando a prova documental, sob pena de preclusão, o mesmos se estendendo à autora, em caso de réplica.

Contestação acompanhada de documentos no Id 128256202-pág.1 e ss.

Réplica no Id 130219371-pág.1 e ss.

É o relatório. Fundamento e decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

II.1- Considerações gerais

Como é cediço, no sistema processual em vigor, o Juiz é o destinatário das provas, e cabe a ele determinar a produção daquelas que julgar essenciais ao deslinde da demanda. É o que dispõe o artigo 370 do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSA A DISPOSITIVO DA CR. COMPETÊNCIA DO STF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que toca à aduzida ofensa ao art. 5º da CR/1988, não compete a esta Corte Superior a sua análise, pois esse mister é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, a, da Carta Magna. 2. Cabe ao Magistrado, como destinatário final do acervo probatório, a análise da necessidade, ou não, da produção das provas requeridas pelas partes. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano no exame dos fatos e provas, confirmou a conclusão do Juízo de primeiro grau e considerou dispensável a produção da prova requerida, em acórdão devidamente fundamentado, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. AgInt no REsp 1724603/DF. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0035083-2. Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150). Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 24/04/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/05/2018.Grifamos

Em síntese, cabe ao juiz avaliar a necessidade de deferir ou não a produção probatória que considerar necessária ao seu convencimento.

De outra banda, ressalto que não se configura cerceamento de defesa a decisão do juiz pelo julgamento antecipado da lide. Nesse sentido:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. FACTORING. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA. REEXAME DA PREMISSA DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". <u>2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender</u>

> substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e oral, por haver documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Precedentes. 3. A mera transcrição de ementas não é suficiente para dar abertura ao apelo especial pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Ad argumentandum tantum, no tocante à questão de fundo, a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto à higidez da nota promissória que aparelha a ação de execução, está em consonância com a jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que: "É lícita a recompra de títulos 'frios' transferidos em operação de factoring" (REsp 419.718/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ de 22/05/2006, p. 191). 5. Agravo interno a que se nega provimento. AgInt no AREsp 1016426/CE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0299754-0. Relator(a): Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) (8400). Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 17/05/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 24/05/2018 - Grifo nosso

Com efeito, caso o magistrado entenda que há elementos suficientes para a formação do seu convencimento, em razão da matéria e dos documentos juntados, o julgamento será antecipado.

Dessa forma, considerando que os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação de um juízo seguro acerca do mérito da demanda, reputo desnecessária a produção de outras provas, notadamente por tratar-se de controvérsia cuja natureza é preponderantemente documental.

Ressalte-se, ainda, que as partes não requereram a produção de quaisquer provas.

Por conseguinte, **julgo antecipadamente o feito**, com esteio no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro.

II.2 – Do Mérito/da obrigação de fazer

Inegável, *in casu*, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vez que há explícita relação jurídica de consumo entre as partes. Nos termos do art. 2° do CDC, a autora enquadra-se na condição de consumidor e a demandada, por sua vez, reveste-

se como fornecedora de serviços, consoante art. 3°, do estatuto supra. Além disso, consoante entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula nº 469, "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde*", já tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, conforme decisão de Id 122365303.

Necessário acrescentar, ainda, que a requerida, por ser pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço, conforme art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos provocados aos consumidores. Nesses termos, para a caracterização dessa modalidade de responsabilidade civil, deve-se aferir a existência de conduta ilícita, a concreção do dano, além da presença do nexo de causalidade entre eles.

Dentre os dispositivos de proteção ao consumidor, menciona-se o artigo 6º, inciso VI, do referido diploma legal, que prevê a prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Além disso, merece destaque o normativo previsto no artigo 47 do CDC, que estabelece que "*as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor*".

De igual modo, devem as prestadoras observar com cautela a necessidade de informar o consumidor, de forma clara e adequada, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6°, III, CDC).

Nesse ponto, é de se observar que o contrato celebrado entre as partes diz respeito à saúde e à vida dos usuários dos planos de saúde, cabendo à operadora fornecer os meios aptos ao tratamento indicado ao beneficiário, em observância à dignidade da pessoa humana, vetor constitucionalmente assegurado.

Pois bem. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte autora é usuária do plano de saúde administrado pela demandada. Além disso, por meio do laudo Médico acostado no Id 114220530-pág.1 e ss, assinado por médico/fisiologista, inexistem dúvidas de que a requerente possui diagnóstico de "fibromialgia" (CID10: R52.1).

A questão a ser analisada demanda verificar se o rol de procedimentos médicos previstos em resolução ANS é exemplificativo ou taxativo; se houve justo motivo para a ré se negar a conceder autorização visando o custeio da medicação

prescrita por indicação médica; se persiste a obrigação de fazer em custear o medicamento e os pressupostos que autorizam o reconhecimento do dano moral indenizável.

Como é cediço, os contratos em geral são regidos, em regra, pelo princípio da *pacta sunt servanda* e da autonomia privada, pelos quais, respectivamente, o contrato deve ser cumprido pelas partes e por estas devem ser estatuídos os seus termos e condições. Diz-se em regra porque é cada vez maior a interferência estatal nas relações privadas a fim de conferir equilíbrio entre os celebrantes no âmbito negocial, como o que ocorre, por exemplo, no estatuto consumerista.

O princípio da função social do contrato, inserido expressamente no art. 421, *caput*, do Código Civil, é um importante exemplo dessa limitação, segundo o qual "*a liberdade contratual será exercida em razão e nos limites da função social do contrato*". A função social do contrato visa, com efeito, atender desiderato que ultrapassa o mero interesse das partes.

Com efeito, o negócio celebrado entre os litigantes é vinculado aos parâmetros objetivos para o fornecimento dos serviços de saúde, sendo regulamentado pela Lei nº 9.656/98 e pela Resolução Normativa nº 465/2021, da ANS, que prevê limitações no tocante à cobertura de determinados tratamentos, medicamentos, terapias, cirurgias, procedimentos e exames.

Nesse ponto, como dito retro, a questão cinge-se em aferir a obrigatoriedade, ou não, do plano demandado em fornecer o medicamento indicado pelo médico à autora.

Pois bem. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, em seu art.10, prevê a cobertura obrigatória mínima para a cobertura de tratamentos; todavia, também indica a exclusão de tratamentos, entre os quais o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto os medicamentos para tratamento neoplásicos; senão, vejamos:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII-Revogado

IX-tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

O art.12 da mesma Lei retro enuncia que:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente

c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar

e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e

f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos;

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

(...).

Da mesma forma, o art. 17, parágrafo único, inciso VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, permite que as operadoras de planos de saúde excluam o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais se dão em ambiente externo, no próprio domicílio do beneficiário do plano. Vejamos:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
>
> - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:
>
> a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
>
> b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou
>
> c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;
>
> II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita;
>
> III - inseminação artificial;
>
> IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e estâncias hidrominerais;
>
> V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA;
>
> **VI - <u>fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;</u> (grifo nosso)**

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

IX - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; e

X - estabelecimentos para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar. - (Grifo nosso)

Do cotejo dos dispositivos supracitados, depreende-se que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamento para tratamento domiciliar, exceto os tratamentos neoplásicos.

A ratificar este entendimento, cito julgados do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Com efeito, a autora alega sofrer de fibromialgia, sendo o medicamento *Bisaliv Power Full 1:100 - Cbd 20mg/Ml, Thc < 0,3% - Frasco 30ml E Bisaliv Power Full 20:1 - Cbd 1mg/Ml, Thc 20mg/Ml - Frasco 30ml,* de uso contínuo, indicado para o tratamento dessa patologia; todavia, referida patologia não está inserida nas exceções da Lei nº 9656/98 e da RN 465/2021, por não ter a mesma natureza neoplásica.

Em que pese a suplicante alegar que o medicamento indicado possui registro na ANVISA, tal fato não afasta as normas previstas na legislação supra, haja vista não ser medicamento antineoplásico, não estando o plano de saúde requerido obrigado a fornecê-lo em âmbito domiciliar.

Nesse ponto, cabe dizer que a autora postula o fornecimento do medicamento para ser usado em domicílio, o que foge à obrigação do plano de saúde em fornecê-lo, de acordo com o previsto na Lei 9.656/98 e Rn 465/2021 da ANS.

A ratificar o entendimento adotado por esta magistrada da não obrigatoriedade de medicamento domiciliar, que não seja antineoplásico, o que é o caso da autora, haja vista sofrer de fibromialgia, cito julgados dos Tribunais Pátrios:

> EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, IV, DA LEI Nº 9.656/98 - NEGATIVA DE COBERTURA - LICITUDE - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. - À luz do artigo 10, inciso IV, da Lei nº 9.656/98, tem-se a obrigatoriedade da cobertura mínima de tratamentos pelos planos de saúde, o qual exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção de medicamentos neoplásicos, ou seja, para o tratamento de câncer. - Considerando que os medicamentos prescritos (à base de Canabidiol) para o tratamento domiciliar da enfermidade da parte autora não se enquadram em tratamento antineoplásico, ausente a obrigatoriedade legal e contratual da cobertura por parte da operadora do plano de saúde apelante. - Se a negativa de cobertura é respaldada em lei e em contrato, não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar o direito de indenizar por danos morais. - Via de consequência, a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - CANABIDIOL - LOMBALGIA, CERVICALGIA, DOR CRÔNICA, SINDROME ANSIO DEPRESSIVA E FIBROMIALGIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PROVIMENTO CONDENATÓRIO - BASE DE CÁLCULO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp n. 1.584.526/SP). A operadora deve fornecer medicamento à base de canabidiol prescrito por profissional médico, amparado no conceito de saúde baseado em evidências. Embora se trate de medicamento sem registro na ANVISA, a autorização para importação "evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia". A

recusa injustificada pela operadora de plano de saúde em custear medicamento essencial à preservação da saúde, agravando a circunstância de vulnerabilidade a qual o consumidor está submetido, implica a obrigação de pagar indenização pelos danos morais causados. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Havendo condenação nas obrigações de pagar indenização e fornecer medicamento, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial deve incidir sobre ambas, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Nas condenações indenizatórias por ato ilícito contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.135325-1/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR DE "ESCLEROSE MÚLTIPLA" - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 10, IV, DA LEI 9.656/98 - NEGATIVA DE COBERTURA LÍCITA. - À luz do art. 10, IV, da Lei 9.656/98, tem-se a obrigatoriedade da cobertura mínima de tratamentos pelos planos de saúde, o qual exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção de medicamentos neoplásicos, ou seja, para o tratamento de câncer, o que não é o caso dos autos. - Desse modo, a negativa de fornecimento do fármaco "Canabidiol" por parte da operadora do plano de saúde revela-se lícita, de forma que, ausente a obrigatoriedade legal e contratual, não há que se falar em ato ilícito praticado capaz de ensejar a procedência do pedido inicial.

V.V. APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - AUSÊNCIA - CERCEIO DE DEFESA - MÁCULA NÃO CONFIGURADA - ESCLEROSE MÚLTIPLA - CANABIDIOL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - FEIÇÃO IRREGULAR

Está livre de nulidade por cerceio de defesa a sentença proferida sem o alargamento probatório que, apesar de invocado pela parte demandada, é despiciendo para exame da questão litigiosa. Não é inepta a petição inicial que, harmoniosa com os artigos 319 e 320 do CPC, consigna causa de pedir e pedido com ela convergente de maneira a tornar conhecidos os exatos contornos da pretensão deduzida e permitir exercício legítimo da ampla defesa. "É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano" (Ag.Rg. no AREsp. 733825/SP ,DJe 16/11/2015). A operadora deve responder pelo custeio de canabidiol quando tecnicamente prescrito num contexto de

inequívoca necessidade para tratamento do paciente e não houve, por ela, demonstração da existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para a hipótese. Apuração da proporcionalidade e razoabilidade na hipótese concreta. A gratuidade de justiça deve ser mantida em proveito do litigante pessoa física quando ausente nos autos prova capaz de demonstrar suposta saúde financeira denunciada pela parte contrária em impugnação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.110246-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 18/07/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENOR - SÍNDROME DE WEST - ÓLEO DE CANABIDIOL - PLANO DE SAÚDE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - ACOLHIMENTO - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE MÉDICAMENTO, NOS MOLDES INDICADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE - EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO NOS MOLDES SOLICITADOS, POR CLÁUSULA CONTRATUAL - MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR - VALIDADE DA EXCLUSÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO - RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição da República, faz jus à gratuidade judiciária a parte requerente desse benefício que apresenta provas sobre sua hipossuficiência financeira para o pagamento das custas e despesas do processuais.

- Para os fins de definição do valor da causa, o valor das prestações vincendas deve corresponder a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, nos termos do artigo 292, § 2.º, do Código de Processo Civil.

- É lícita a exclusão de cobertura, pelas Operadoras de Plano de Saúde, de fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, por encontrar respaldo no artigo 10, inciso VI, da Lei Federal n.º 9.656/1998, à exceção dos medicamentos utilizados para tratamento de neoplasia maligna. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.276356-9/003, Relator(a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023).

Desta forma, não há que se falar em conduta ilícita praticada pelo demandado, ou em reparação pelos danos morais que a autora alega ter sofrido.

III – DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **rejeito os pedidos iniciais**, à falta de amparo legal.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, **ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, por ser a demandante beneficiária da Justiça Gratuita.**

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Timon, 16 de maio de 2025.

Juíza Susi Ponte de Almeida

Titular da 2ª Vara Cível de Timon

Assinado eletronicamente por: **SUSI PONTE DE ALMEIDA** 25051619301976500000138168358
16/05/2025 19:30:19
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF